Polissonografia domiciliar (tipo II)

Neurologia e Sono — Avenida Brasil 1500, Funcionários
Alameda Oscar Niemeyer 119, sala 201, Vila da Serra
(31) 3317-7267 — neurologiaesono.com

Nome: FELIPE DINIZ PAIVA
Nascimento: 06/01/1989
Idade: 37 anos
Indicação:

Data do exame: 17/10/2026
Duração do exame: 07h36min
Médico solicitante: Dra. Taina Leite Machado
IMC: 26,87 kg/m²

O que foi examinado

O exame foi feito na sua casa, durante a noite, em ar ambiente, com um aparelho portátil que você mesmo instalou depois da orientação recebida na clínica. Enquanto você dormia, sensores registraram a atividade elétrica do cérebro, a passagem de ar pelo nariz, os movimentos de respiração do tórax e do abdome, a quantidade de oxigênio no sangue, a frequência do pulso, o ronco e a posição do corpo. O aparelho de casa não registra os movimentos dos olhos nem a atividade dos músculos, de modo que as fases do sono foram estimadas a partir da atividade cerebral, em trechos de 30 segundos, segundo os critérios da Academia Americana de Medicina do Sono.

Conclusão

1 - Apneia obstrutiva do sono de grau leve, com índice de apneia e hipopneia de 5,12 eventos por hora de sono e índice de distúrbio respiratório de 8,34 por hora.

2 - Dessaturação de oxigênio com nadir de 88%, saturação média de 92,5% e 0,26% do tempo de sono abaixo de 90% (índice de dessaturação de 3% de 1,17 por hora).

3 - Arquitetura do sono com eficiência de 90,0% e sono de ondas lentas praticamente ausente.

4 - Polissonografia domiciliar (tipo II), com estadiamento estimado pelo eletroencefalograma sem eletrooculograma e eletromiograma.

Comentários técnicos

Arquitetura do sono. O período de registro compreendeu 456,0 minutos (07h36min), com tempo total de sono de 410,5 minutos (06h50min) e eficiência de 90,0%. A latência para o início do sono foi de 0,0 minutos e a latência para o primeiro episódio de sono REM, de 148,0 minutos. O paciente permaneceu 45,5 minutos acordado após o início do sono, com 26 despertares. A distribuição dos estágios foi de 0,1% em N1, 79,0% em N2, 1,3% em N3 e 19,5% em sono REM.

Microdespertares. Foram identificados 78 microdespertares ao longo do sono, correspondendo a um índice de 11,41 por hora.

Eventos respiratórios. Foram pontuadas 1 apneia e 34 hipopneias, resultando em índice de apneia e hipopneia (IAH) de 5,12 eventos por hora de sono. Somados 22 despertares relacionados a esforço respiratório, o índice de distúrbio respiratório (RDI) foi de 8,34 por hora. Dos 35 eventos, 14 cursaram com dessaturação e 20 terminaram em despertar. A duração mediana das hipopneias foi de 26 segundos, com evento mais longo de 172 segundos. O índice em sono REM foi de 6,00 por hora contra 4,91 por hora em sono NREM, razão de 1,22. Em decúbito dorsal (182 minutos de sono) o índice foi de 6,26 por hora; fora dele (228 minutos), de 4,21 por hora.

Oximetria. A saturação média de oxigênio durante o sono foi de 92,5%, com nadir de 88%. O tempo com saturação abaixo de 90% foi de 1,1 minutos, equivalente a 0,26% do tempo de sono. O índice de dessaturação de 3% foi de 1,17 por hora e o de 4%, de 0,59 por hora.

Qualidade do registro

O equipamento registrou das 22:00 às 06:00 (08h00min). O período analisado, delimitado pelo início do sinal dos sensores e pela posição corporal, foi das 22:00 às 05:36 (07h36min).

O estadiamento foi estimado a partir das derivações C3-M2 e C4-M1, sem eletrooculograma e sem eletromiograma do mento. O eletroencefalograma apresentou sinal utilizável em praticamente todo o período.

Fluxo e oximetria apresentaram sinal válido durante praticamente todo o sono, e os índices foram calculados sobre o tempo total de sono estimado. O oxímetro ficou sem leitura por 25 minutos ao longo do registro, períodos que foram excluídos das medidas.

Quanto ao esforço respiratório, a cinta torácica não forneceu sinal durante o registro; a cinta abdominal não forneceu sinal durante o registro. Na ausência de sinal de esforço utilizável, 13 dos 35 eventos respiratórios apresentaram ronco no próprio evento ou nas respirações imediatamente vizinhas e foram caracterizados como obstrutivos; nos 22 demais, sem ronco, não foi possível distinguir obstrutivo de central.

O paciente permaneceu 42% do período analisado em decúbito dorsal e 58% em decúbito lateral.

Entendendo o seu exame

As páginas a seguir explicam, em linguagem acessível, o que cada medida do exame significa e o que os seus resultados mostram. Os valores são os seus, e os comentários foram escritos a partir deles.

Para que serve esta parte do laudo.

Ela descreve e explica o que foi registrado na noite do exame. Não substitui nem antecipa a avaliação do seu médico: a indicação de investigação e de tratamento cabe a quem acompanha o seu caso, que conhece a sua história, o seu exame físico e o conjunto da sua saúde — coisas que um exame de uma noite não alcança. O objetivo aqui é que você chegue à consulta entendendo o seu exame, para conversar melhor com ele.

Escala de sonolência de Epworth

soma das notas de 0 a 3 em oito situações do dia a dia

1 de 24 (referência: até 10)

A escala de Epworth, que você respondeu no questionário antes do exame, mede a chance de cochilar em situações comuns, como lendo, vendo televisão ou parado no trânsito. Ela não é medida durante a noite: traduz como o seu dia tem sido. O seu resultado está dentro do esperado, sem sonolência diurna excessiva pelas suas respostas.

Eficiência do sono

tempo dormindo ÷ tempo de registro × 100

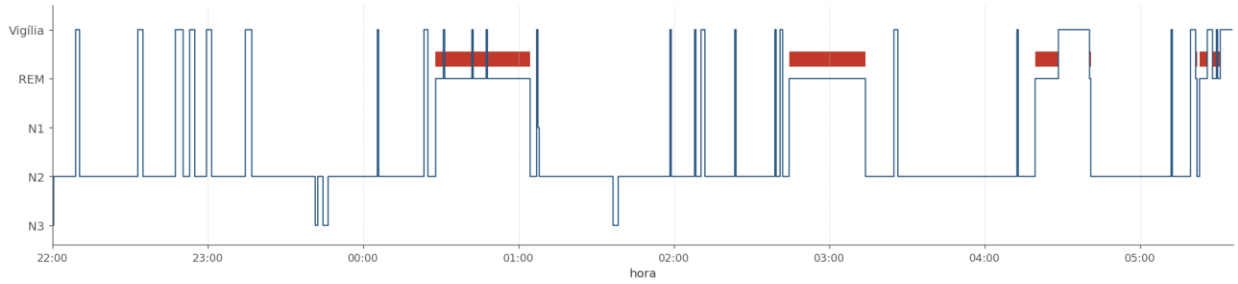
90,0% (referência: acima de 85%)

A eficiência mede quanto do tempo deitado você realmente passou dormindo. A sua está dentro do esperado: o sono se manteve contínuo, sem longos períodos acordado durante a noite.

	Seu resultado
Tempo total de registro	07h36min
Tempo realmente dormindo	06h50min
Tempo acordado após ter adormecido	45,5 min
Tempo para adormecer	0,0 min

Você adormeceu em 0,0 minutos. Adormecer muito rápido pode indicar privação de sono acumulada ou efeito de medicação sedativa, e merece ser conversado na consulta.

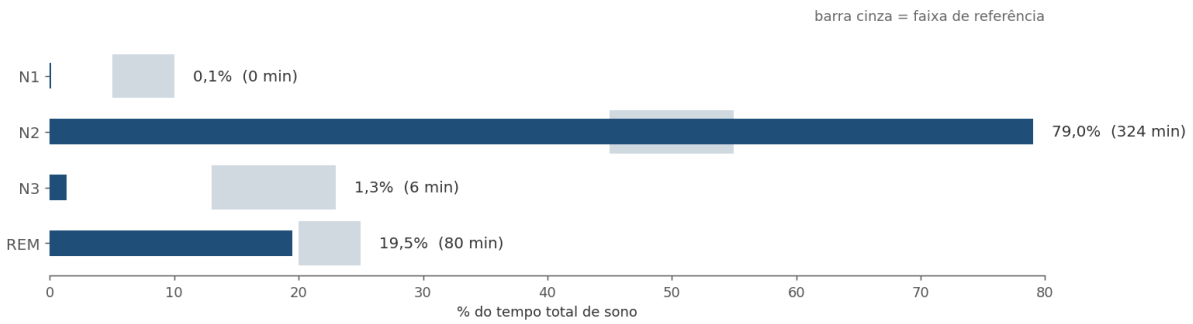
Como o seu sono se organizou ao longo da noite



O hipnograma mostra, minuto a minuto, em que fase do sono você esteve. A linha sobe quando o sono fica mais superficial e desce quando fica mais profundo. No exame domiciliar as fases são uma estimativa feita a partir da atividade cerebral, sem o registro dos olhos e dos músculos.

Ao longo da noite o sono se organiza em ciclos de aproximadamente 90 minutos, cada um passando pelo sono leve, pelo sono profundo e terminando em sono REM. No seu exame foram identificados 3 ciclos completos. O primeiro episódio de sono REM demorou 148,0 minutos para aparecer, bem mais do que os 90 a 120 minutos habituais. Esse atraso é visto com frequência em quem usa antidepressivos e também pode decorrer de despertares repetidos no início da noite.

As fases do seu sono



Sono leve (N1 e N2) — 79,2% da noite

É a maior parte do sono normal e corresponde à transição e à manutenção do sono. Nessas fases o despertar acontece com facilidade. No seu exame: N1 com 0,1% e N2 com 79,0% do tempo dormido.

Sono profundo (N3) — 1,3% da noite

É a fase da recuperação física, da restauração do corpo e da sensação de ter descansado. No seu exame ela apareceu de forma muito reduzida. Isso ajuda a explicar a sensação de sono que não repõe as energias. Vale lembrar que o sono profundo diminui naturalmente com a idade, e que o critério usado para identificá-lo é de amplitude das ondas cerebrais, o que torna o achado mais frequente a partir dos 60 anos.

Sono REM — 19,5% da noite

É a fase dos sonhos, ligada à memória, ao aprendizado e ao equilíbrio emocional. Durante o REM os músculos ficam relaxados, inclusive os da garganta, e por isso é a fase em que os eventos respiratórios tendem a ser mais intensos. A sua proporção está dentro do esperado.

Despertares durante a noite

Foram registrados 26 despertares ao longo da noite, somando 45,5 minutos acordado depois de ter adormecido. Despertares breves são normais e quase sempre não são lembrados. O que importa é a frequência: quando se repetem muitas vezes, interrompem a progressão natural do sono e impedem que ele aprofunde, gerando cansaço mesmo após uma noite inteira na cama.

A sua respiração durante o sono

Índice de apneia e hipopneia (IAH)

número de pausas e reduções da respiração por hora de sono

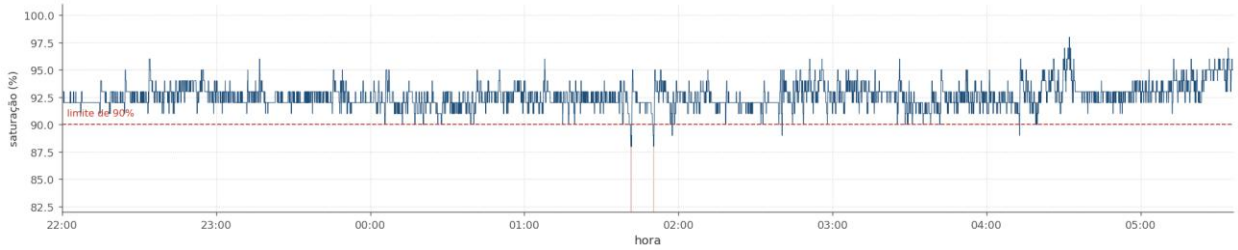
5,12/h (leve)

Classificação	Faixa	Seu caso
Normal	abaixo de 5/h	
Leve	5 a 15/h	✓
Moderado	15 a 30/h	
Grave	acima de 30/h	

A apneia é a interrupção da passagem de ar por pelo menos dez segundos; a hipopneia é a redução importante dessa passagem, com queda de oxigênio ou despertar. No seu exame foram registradas 1 apneia e 34 hipopneias.

Foram ainda identificados 22 despertares relacionados ao esforço para respirar, eventos em que a respiração não chega a reduzir o suficiente para ser contada como hipopneia, mas o esforço desperta o cérebro. Somados ao IAH, resultam num índice de distúrbio respiratório de 8,34 por hora.

A sua oxigenação durante o sono



	Seu resultado	Referência
Saturação média durante o sono	92,5%	acima de 94%
Menor saturação da noite	88%	acima de 90%
Tempo com oxigênio abaixo de 90%	1,1 min (0,3%)	abaixo de 1%
Quedas de oxigênio por hora	1,17/h	abaixo de 5/h

A sua oxigenação se manteve adequada na maior parte da noite, com quedas pontuais acompanhando os eventos respiratórios. O padrão é de quedas cíclicas — que sobem e descem junto com a respiração — e não de oxigênio persistentemente baixo, que seria mais preocupante.

Seu peso e suas medidas

	Seu resultado	Referência
Peso	90,0 kg	—

	Seu resultado	Referência
Altura	1,83 m	—
Índice de massa corporal (IMC)	26,87	18,5 a 24,9

O seu IMC está na faixa de sobrepeso. O peso influencia diretamente a apneia do sono, porque a gordura ao redor da faringe estreita a passagem de ar. Uma redução modesta, da ordem de 5% a 10% do peso, já costuma repercutir de forma mensurável sobre o número de eventos respiratórios.

Hábitos que influenciam o seu sono

Álcool

O álcool encurta o tempo para adormecer, mas é um relaxante muscular: reduz o tônus da garganta e torna as pausas respiratórias mais longas e as quedas de oxigênio mais profundas. Também suprime o sono profundo na primeira metade da noite e provoca despertares na segunda. A recomendação é evitá-lo nas três a quatro horas antes de deitar.

Cafeína

O efeito da cafeína dura bem mais do que a sensação de alerta: metade da dose ainda está no organismo cinco a seis horas depois, e em parte das pessoas esse tempo é bem maior. Café após as 15 ou 16 horas atrapalha o sono daquela noite mesmo em quem afirma dormir bem depois de tomá-lo. Vale lembrar que chá preto, chá mate, refrigerantes à base de cola, chocolate e energéticos também contêm cafeína.

Telas e luz à noite

A luz das telas, especialmente de perto e no escuro, atrasa a liberação da melatonina e empurra o horário do sono para mais tarde. O conteúdo também conta: notícias, trabalho e discussões ativam e dificultam o relaxamento. O ideal é reduzir o brilho e encerrar o uso cerca de uma hora antes de deitar.

Horários

O corpo regula o sono por um relógio interno que depende da regularidade. Dormir e acordar sempre nos mesmos horários, inclusive nos fins de semana, é a medida isolada mais eficaz para consolidar o sono. A exposição à luz natural logo ao acordar ajuda a firmar esse ritmo.

Atividade física

O exercício regular aumenta o sono profundo e reduz o tempo para adormecer, além de contribuir para o controle do peso. Exercícios intensos nas duas horas que antecedem o deitar podem, em algumas pessoas, atrapalhar o início do sono.

Medidas habitualmente discutidas em casos como o seu

O que segue não é prescrição, e sim o repertório de medidas que costuma ser considerado diante de achados como os seus. Quais se aplicam a você, e em que ordem, é decisão a tomar com o seu médico.

- **O seu sono apresentou muitos despertares.** Vale revisar o ambiente — ruído, temperatura, luminosidade e conforto do colchão — e também as idas ao banheiro, evitando grandes volumes de líquido nas duas horas antes de deitar.
- **O seu sono profundo esteve reduzido.** Álcool à noite, horários irregulares e eventos respiratórios são as causas mais comuns e reversíveis. A regularidade de horário e a atividade física são as medidas que mais o favorecem.
- **O peso é o fator mais modificável no seu caso.** Uma redução de 5% a 10% já costuma produzir melhora mensurável do número de eventos respiratórios.
- **Posição para dormir.** Em boa parte dos pacientes os eventos respiratórios são mais frequentes e mais longos ao dormir de barriga para cima, porque a língua e o palato mole caem para trás. Dormir de lado é uma medida simples e sem custo que vale ser testada.
- **Respiração nasal.** Obstrução nasal por rinite, desvio de septo ou sinusite aumenta o esforço respiratório e piora o ronco. Tratar a obstrução nasal melhora o conforto do sono e também a adaptação a eventuais tratamentos.

Opções de tratamento que existem para esse tipo de achado

A lista a seguir é informativa e descreve o que existe, não o que está indicado para você. Nenhuma delas é recomendada por este laudo. A escolha — inclusive a de não tratar, que muitas vezes é a correta — depende da gravidade, dos sintomas, das suas condições de saúde e da sua preferência, e pertence ao médico que acompanha o seu caso. O propósito de apresentá-las é que você chegue à consulta sabendo do que se trata.

- **Medidas comportamentais.** Controle do peso, posição para dormir, suspensão do álcool à noite, regularidade de horários e tratamento da obstrução nasal. São a base do tratamento em qualquer grau de gravidade e, nos casos leves, podem ser suficientes.
- **Aparelho intraoral.** Dispositivo feito sob medida por dentista com formação na área, usado durante a noite para avançar a mandíbula e ampliar o espaço da via aérea. É uma boa alternativa nos casos leves e moderados e em quem não se adapta ao CPAP.
- **CPAP.** Aparelho que fornece ar sob pressão por uma máscara, mantendo a via aérea aberta durante o sono. É o tratamento mais eficaz para a apneia obstrutiva e age desde a primeira noite de uso adequado. Exige um período de adaptação e ajuste da máscara, que faz toda a diferença no resultado.
- **Terapia posicional.** Dispositivos que impedem a permanência de barriga para cima durante a noite, úteis quando os eventos se concentram nessa posição.
- **Avaliação otorrinolaringológica.** Indicada para identificar obstruções corrigíveis — amígdalas aumentadas, desvio de septo, hipertrofia de cornetos — que podem ser tratadas e, em casos selecionados, resolver ou atenuar o quadro.

Em casos com índice na faixa leve, a conduta inicial costuma privilegiar as medidas comportamentais, reservando os dispositivos para quando há sintomas importantes ou doenças associadas. Se é esse o seu caso, quem avalia é o seu médico.

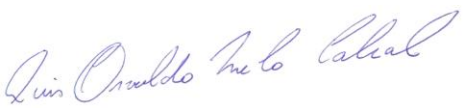
Por que tratar e quando reavaliar

A apneia do sono não tratada repercute além do cansaço. As quedas repetidas de oxigênio e os despertares acionam o sistema nervoso autônomo dezenas de vezes por noite, com elevação da pressão arterial, sobrecarga do coração e liberação de hormônios de estresse. A longo prazo associa-se a hipertensão de difícil controle, arritmias — em especial a fibrilação atrial — , infarto, acidente vascular cerebral, piora do controle da glicemia e ganho de peso. No dia a dia manifesta-se como sonolência, dificuldade de concentração e de memória, irritabilidade e queda do rendimento.

Com índice na faixa leve, convém reavaliar em um a dois anos, ou antes disso se houver aumento de peso, piora da sonolência ou surgimento de pressão alta de difícil controle.

Leve este documento à consulta.

Ele descreve o que foi registrado na noite do exame e explica o significado de cada medida. A decisão sobre o que fazer a partir daí depende do conjunto do seu quadro — sintomas, exame físico, outras condições de saúde, tratamentos em curso — e é do médico que solicitou o exame e acompanha você. Este laudo se destina a apoiar essa avaliação, não a substituí-la.



Dr. Luis Osvaldo Melo Cabral
CRM-MG 32446
Especialista em Neurologia Clínica (HC-UFMG) — RQE 9249
Especialista em Neurofisiologia Clínica (SBNC) — RQE 41410
Membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia

Obs.: os achados deste exame refletem apenas uma descrição dos sinais biológicos captados, não estando, necessariamente, relacionados à causa dos sintomas ou à conduta médica, o que deve ser orientado e determinado pelo médico assistente.